



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN
INSTALASI KAMAR OPERASI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 713.2.1/I-PDM/IKO/VIII/2025

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi

Disusun oleh :
Kepala Instalansi Kamar Operasi (IKO)



dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Disetujui oleh :

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi (IKO) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi (IKO) ini meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit..

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi (IKO) ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 Agustus 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENORGANISASIAN INSTALASI KAMAR OPERASI

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp. An.
3. Siti Durotul Ibadiyah, S.Kep., Ns.
4. Anita sari, Amd. Keb.
5. Afni Pandiyagaleni, S. Kep., Ns.
6. Rendhi Adyatma, Amd. Kep.
7. Kiki Sandra, Amd. Kep.
8. Kurnia Setyawansyah, S.Kep., Ns.
9. Yurike Devita, S. Kep., Ns.
10. Eko Pambudi, Amd. Kep.
11. Ferry Kuswantoro, S. Kep., Ns.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	2
2.1 Deskripsi RS Prima Husada	2
2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada	2
BAB 3 VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN	4
3.1 Visi	4
3.2 Misi	4
3.3 Falsafah	4
3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	4
3.5 Tujuan	4
3.6 Motto	4
BAB 4 STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA	5
4.1 Bagan Organisasi	5
4.2 Keterangan/pengertian	6
BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI KAMAR OPERASI	8
BAB 6 URAIAN JABATAN	9
6.1 Uraian jabatan	9
6.2 Tugas Klinis	15
BAB 7 TATA HUBUNGAN KERJA	22
7.1 Pola Hubungan Kerja	22
BAB 8 POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI	24
8.1 Pola Ketenagaan	24
8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf	25
8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf	26
8.4 Jumlah Staf Unit	26
8.5 Seleksi Calon Karyawan	26
8.6 Pengembangan SDM	27
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI	28
BAB X PERTEMUAN RAPAT	30
BAB XI PELAPORAN	31
11.1 Pengertian	31
11.2 Jenis Laporan	31

DAFTAR TABEL

6.1 Uraian Jabatan	9
7.1 Tabel Pola Hubungan dengan Instalasi / Unit Pelayanan Struktural	22
7.2 Tabel Pola Hubungan dengan Instalasi/Unit Penunjang	22
8.4 Tabel Kualifikasi Ketenagaan Instalasi Kamar Operasi	26

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 713.2.1/I-PDM/IKO/VIII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KAMAR OPERASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi yang bermutu tinggi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi (IKO).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 (tentang Standarisai Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KAMAR OPERASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Pedoman Pengorganisasian Instalasi kamar Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.



Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi kamar Operasi digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi kamar Operasi di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 713.2.1/I-PDM/IKO/VIII/2025
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI KAMAR OPERASI (IKO)

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Menurut *American Hospital Association* (1974) Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rumah Sakit Prima Husada adalah rumah sakit swasta yang berada di Kota Malang. Dalam perkembangan industri perumahsakitian yang kompetitif ini, Rumah Sakit Prima Husada juga harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Prima Husada antara lain Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Kamar Operasi, dan lain-lain.

Instalasi kamar operasi adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pembedahan, anestesi dan sedasi ringan, sedang dan dalam untuk memenuhi kebutuhan pasien baik untuk tindakan elektif maupun emergensi di luar jam kerja. Sebagai salah satu bagian dari Rumah Sakit Prima Husada, Instalasi Kamar Operasi memberikan pelayanan tindakan pembedahan, anestesi maupun sedasi dengan dilengkapi peralatan yang memadai dan juga didukung oleh SDM yang memiliki sertifikasi dan pelatihan yang khusus dibidangnya serta memenuhi persyaratan dan standar di rumah sakit, nasional, undang-undang, dan peraturan yang berlaku.

Rumah sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan wajib berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. Untuk mencapai keberhasilan itu maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Pusat sterilisasi merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk pengendalian infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Sterilisasi adalah suatu proses pengolahan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk endospora dan dapat dilakukan dengan proses kimia atau fisika.

Upaya untuk mendukung peningkatan mutu dan terlaksananya program kerja di bagian masing-masing diperlukan SDM yang berkualitas. Seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia yang baik diharapkan sebuah institusi dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1 Deskripsi RS Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email primahusadamalang@gmail.com/info@rs-primahusada.id, website www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	:	Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	:	Menjadi tempat dokter internsip

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5 Tujuan

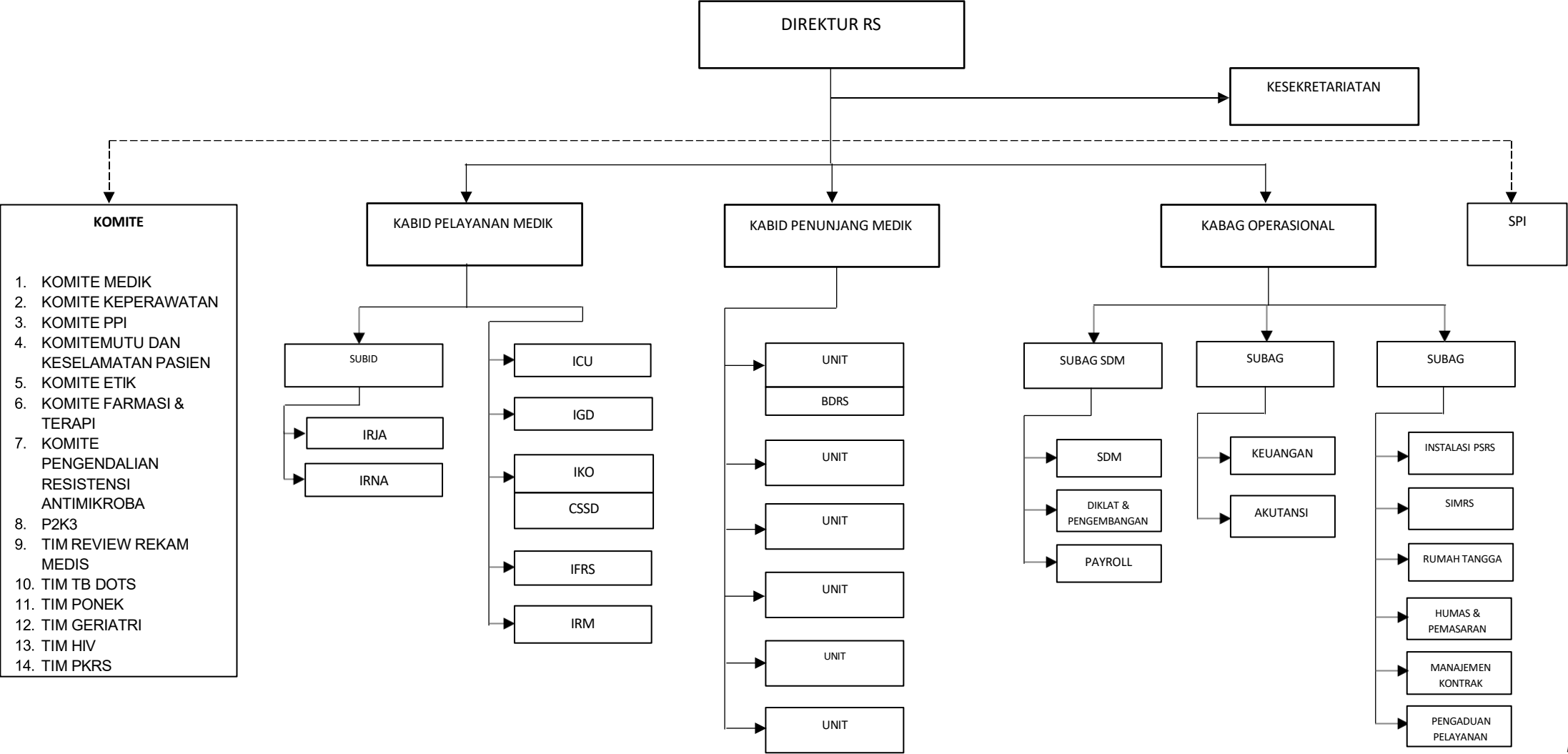
Rumah Sakit Prima Husada memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada.

3.6 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI RS. PRIMA HUSADA

4.1. BAGAN ORGANISASI



4.2 Keterangan/Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
 - 2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
 - 3) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.
-

c. Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membatu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

d. Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membatu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

- 1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.
- 3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KONtrak dan Pengaduan Pelayanan

e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
 - a) Kepala Instalasi Rawat Inap
 - b) Kepala *Intensive Care Unit*
 - c) Kepala Instalasi Gawat Darurat
 - d) Kepala Instalasi Kamar Operasi
 - e) Kepala Instalasi Farmasi
 - f) Kepala Instalasi Rekam Medis
 - g) Kepala Unit Laboratorium
 - h) Kepala Unit Radiologi
 - i) Kepala Unit Gizi
 - j) Kepala Unit Laundry
 - k) Kepala Unit Kamar Jenazah
 - l) Kepala Unit Fisioterapi
 - m) Kepala Bagian SDM
 - n) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - o) Kepala Bagian Umum

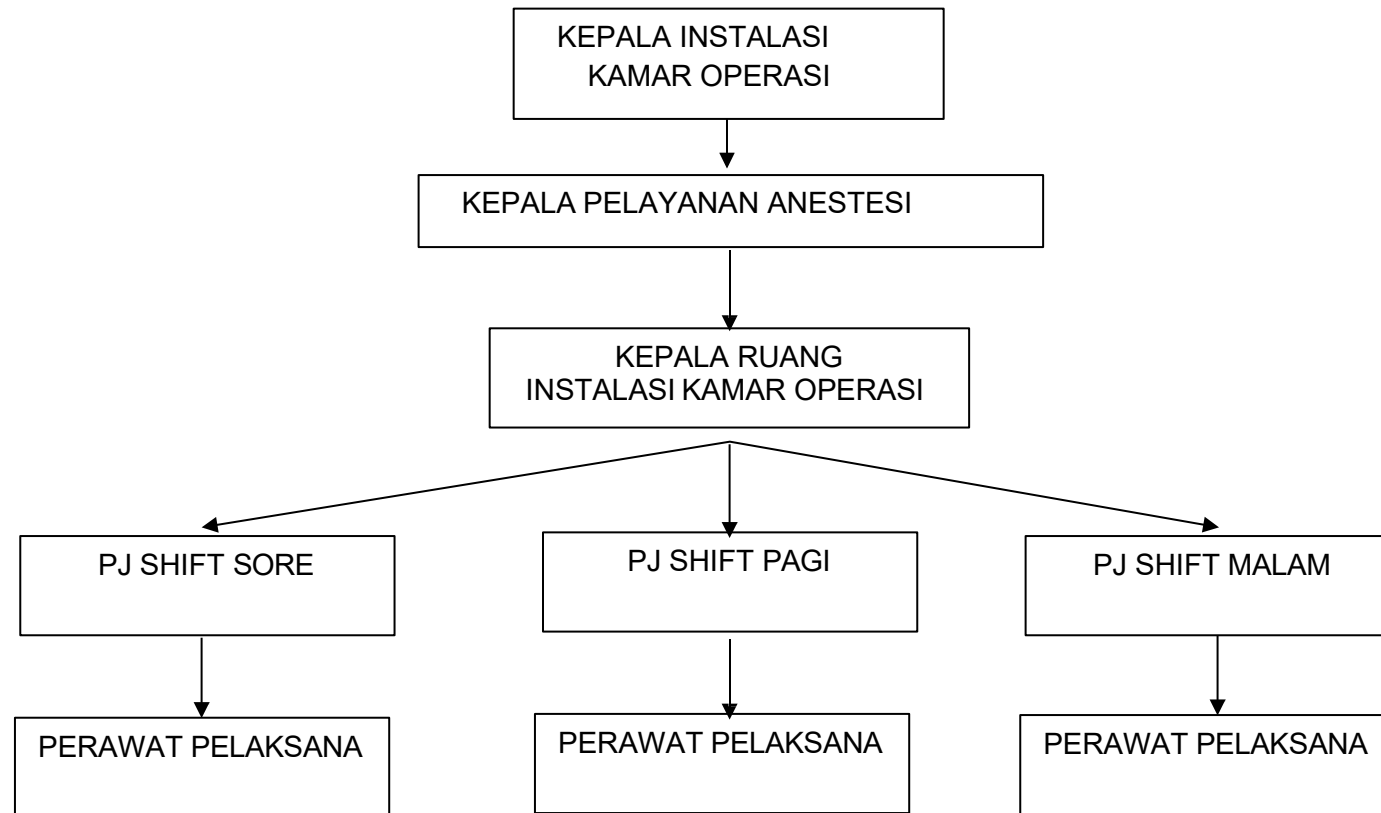
2) Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/Panitia/Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

- a) Komite Medik
- b) Komite Keperawatan
- c) Komite PPI
- d) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e) Komite Etik
- f) Komite Farmasi & Terapi
- g) Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i) Tim Review Rekam Medis
- j) Tim TB DOTS
- k) Tim PONEK
- l) Tim Geriatri
- m) Tim HIV
- n) Tim PKRS
- o) Tim Casemix

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI KAMAR OPERASI



BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1 Uraian Jabatan

No.	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
1	Kepala Instalasi Kamar Operasi	a. Pendidikan: 1) Dokter spesialis bedah atau dokter spesialis anestesi. 2) Memiliki SIP di RS Prima Husada b. Sertifikasi: 1) Memiliki sertifikasi ACLS dan BCLS. 2) Memiliki sertifikasi code blue. 3) Memiliki sertifikasi Mutu dan keselamatan pasien. 4) Memiliki sertifikasi penanggulangan bencana. 5) Memiliki sertifikasi komunikasi efektif. c. Pengalaman Kerja: Pengalaman di bidang kamar operasi minimal 3 tahun d. Keterampilan: Memiliki keterampilan dalam hal Kepemimpinan Uraian Tugas a. Bertanggung jawab terhadap skema pengelolaan pasien Instalasi Kamar Operasi. b. Melaksanakan pembinaan karyawan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Kamar Operasi. c. Membuat penilaian terhadap kinerja karyawan di Instalasi Kamar Operasi. d. Memantau seluruh karyawan dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan dan tugas yang berlaku di Instalasi Kamar Operasi. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembedahan dan pengelolaan Instalasi Kamar Operasi. b. Bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan visi dan misi Instalasi Kamar Operasi. Wewenang:

		a. Memeriksa hasil kegiatan seluruh karyawan. b. Menilai kinerja karyawan. c. Memberi usulan mengenai penambahan peralatan di Instalasi Kamar Operasi. d. Menilai, menegur, memberi sanksi dan memotivasi bawahan di bagian Instalasi Kamar Operasi. e. Mengusulkan untuk pengembangan karyawan. f. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja yang lain yang terkait. g. Mendelegasikan tugas kepada karyawan yang berwenang dan kompeten.
No.	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
2	Kepala Pelayanan Anestesi	a. Pendidikan: 1) Dokter spesialis anestesi. 2) Memiliki SIP di RS Prima Husada b. Sertifikasi: 1) Memiliki sertifikasi ACLS dan BCLS. 2) Memiliki sertifikasi code blue. 3) Memiliki sertifikasi Mutu dan keselamatan pasien. 4) Memiliki sertifikasi penanggulangan bencana. 5) Memiliki sertifikasi komunikasi efektif. c. Pengalaman Kerja: - Pengalaman di bidang kamar operasi minimal 3 tahun d. Keterampilan: - Memiliki keterampilan dalam hal Kepemimpinan
		Uraian Tugas: 1. Mengoordinasi kegiatan pelayanan anestesiologi dan sedasi sesuai dengan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia; 2. Melakukan koordinasi dengan bagian/ SMF/Instalasi terkait 3. Mengawasi pelaksanaan pelayanan anestesia setiap hari; 4. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan anestesia; 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala.
		Tanggung Jawab 1. Menjamin kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan anestesiologi dan sedasi; 2. Menjamin sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar; 3. Menjamin dapat terlaksananya pelayanan anestesiologi dan sedasi

		yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien; 4. Menjamin terlaksananya program kendali mutu dan kendali biaya; 5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pelayanan anestesiologi dan sedasi secara berkesinambungan 6. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesiologi dan sedasi yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien; 7. Pelaksanaan pencatatan, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan di dalam rumah sakit; 8. Pelaksanaan program menjaga mutu pelayanan anestesia dan keselamatan pasien di dalam rumah sakit.
		Wewenang: 1. Memeriksa hasil kegiatan seluruh pelayanan anestesi. 2. Memberi usulan mengenai penambahan peralatan untuk pelayanan anestesi. 3. Menilai, menegur, memberi sanksi dan memotivasi anggota tim anestesi. 4. Mengusulkan untuk pengembangan karyawan. 5. Meminta masukan dari anggota dan unit kerja yang lain yang terkait. 6. Mendelegasikan tugas kepada anggota yang berwewenang dan kompeten.
3	Kepala Ruang Kamar Operasi.	a. Pendidikan: 1) Lulusan S1 Keperawatan 2) Memiliki STR Keperawatan / STR penata anestesi, SIKP yang masih berlaku b. Sertifikasi: 1) Instrumentator Kamar Operasi 2) Pelatihan Anestesi c. Pengalaman Kerja: Pengalaman di bidang kamar operasi minimal 3 tahun d. Keterampilan: Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
		Uraian Tugas:

		a. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengeluaran di Instalasi Kamar Operasi. b. Menyusun rencana kegiatan pembedahan berdasarkan jumlah dan kemampuan operasi. c. Menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab kepada karyawan. d. Melakukan pembagian tugas harian dan memperhitungkan jumlah dan kemampuan karyawan dalam pelaksanaan pembedahan. e. Menyusun program pengembangan karyawan Instalasi Kamar Operasi. f. Membuat jadwal dinas sebulan sekali. g. Menyusun jadwal jaga harian. h. Membuat laporan berkala kepada kepala Instalasi Kamar Operasi dan kepala bidang pelayanan medik. i. Melakukan perawatan dan pemeliharaan semua peralatan Instalasi Kamar Operasi. j. Melaporkan kepada kepala Instalasi Kamar Operasi dan kepala bidang pelayanan medik bila terjadi kerusakan peralatan dikamar operasi. k. Menyusun rencana kegiatan tahunan Instalasi Kamar Operasi. l. Membuat rencana anggaran tahunan (TOR) Instalasi Kamar Operasi. m. Menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan Instalasi Kamar Operasi. n. Memantau seluruh karyawan dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan dan tugas yang berlaku di instalasi kamar operasi. o. Mengatur pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. p. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain berkaitan dengan kegiatan di Instalasi Kamar Operasi.
		Tanggung Jawab
		a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembedahan dan pengelolaan Instalasi Kamar Operasi. b. Bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. c. Bertanggung jawab terhadap peralatan di Instalasi Kamar Operasi. d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi Instalasi Kamar Operasi. e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi. f. Bertanggung jawab kepada kepala Instalasi Kamar Operasi dan kepala

		bidang pelayanan medik.
		Wewenang:
		a. Memeriksa hasil kegiatan seluruh karyawan. b. Menilai, menegur, memberi sanksi dan memotivasi bawahan di Instalasi Kamar Operasi. c. Mendapat laporan hasil kerja bawahan. d. Mengusulkan untuk pengembangan karyawan. e. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja yang lain yang terkait. f. Mendelegasikan tugas kepada karyawan yang berwewenang dan kompeten. g. Membuat dan menandatangani kwitansi kegiatan operasi.
No.	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
4	Perawat Asisten Bedah	a. Pendidikan: Lulusan S1 Keperawatan b. Sertifikasi: 1) Memiliki STR Keperawatan / STR penata anestesi, SIKP yang masih berlaku 2) Menguasai betul atau fasih teknik aseptik antiseptik. 3) Mengenal dengan baik teknik operasi yang dilakukan dan kemungkinan kegawatan. 4) Mampu mengelola pasien gawat. 5) Mengenal dengan baik instrumentasi yang diperlukan. 6) Pengalaman : c. Pengalaman Kerja: Pengalaman di bidang kamar operasi minimal 3 tahun d. Keterampilan: 1) Mengenal karakteristik operator. 2) Mempunyai kecepatan kerja yang tinggi dan baik. Teliti dan cekatan.
		Uraian Tugas

		a. Sebelum Pembedahan 1) Berkomunikasi dengan operator mengenai rencana tindakan operasi dan kemungkinan komplikasi. 2) Memastikan area operasi siap pakai. 3) Membantu instrumen menyiapkan kelengkapan operasi (instrumen steril, bahan habis pakai operasi). 4) Memastikan kesiapan kegawatan. 5) Memastikan kesiapan fasilitas ruangan operasi. 6) Membantu mempersiapkan posisi pasien. 7) Membantu operator melakukan desinfektan. 8) Membantu operator drapping. 9) Berkoordinasi dengan tim anestesi tentang kesiapan tindakan operasi dan kondisi pasien. b. Saat pembedahan 1) Membantu operator dalam membuka lapang pandang operator saat dilakukan tindakan pembedahan. 2) Membantu operator dalam setiap tindakan. 3) Memantau dan meminimalkan perdarahan. 4) Mengawasi kondisi pasien dan berkomunikasi dengan operator. 5) Mengawasi kinerja instrumen. 6) Mengantisipasi kebutuhan operator baik kebutuhan personal maupun kebutuhan tindakan operasi selangkah di depan operator. c. Setelah pembedahan. 1) Menutup luka dengan teknik steril. 2) Membersihkan bagian tubuh pasien yang dioperasi. 3) Melengkapi keperluan PA. 4) Memberi edukasi kepada pasien dan keluarga. 5) Membantu transfer pasien dari ruang operasi ke ruang pulih sadar. 6) Memeriksa ulang catatan dan dokumentasi pembedahan. 1) Memeriksa dan menghitung semua instrumen sesuai inventaris sebelum diserahkan ke kamar steril
		Tanggung Jawab

		a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembedahan. b. Bertanggung jawab terhadap bahan PA yang akan dikirim untuk pemeriksaan dan memberitahukan kepada keluarga. c. Bertanggung jawab terhadap penyerahan <i>specimen</i> kepada keluarga. d. Bertanggung jawab terhadap jumlah instrumen dan alat lainnya dalam pelaksanaan pembedahan. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas-berkas pasien yang dilakukan operasi (operasi lokal anestesi)
		Wewenang a. Memastikan tindakan operasi yang diikuti bersama tim berjalan dengan baik dan lancar. b. Memberi masukan kepada operator bila diperlukan. Memastikan tidak ada kekeliruan pada saat operasi.
No.	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
5	Perawat Instrumen	a. Pendidikan Minimal S1 Keperawatan b. Sertifikasi: 1) Memiliki Sertifikat Instrumentator kamar operasi 2) Memiliki sertifikasi BCLS. c. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja di kamar operasi minimal 1 tahun d. Keterampilan: 1) Memiliki sertifikasi instrumen dasar kamar operasi. 2) Memiliki sertifikasi <i>code blue</i>. 3) Memiliki sertifikasi penanggulangan bencana. Memiliki sertifikasi komunikasi efektif.
		e. Uraian Tugas
		a. Sebelum Pembedahan. 1) Menyiapkan keperluan operasi (set instrumen steril, bahan habis pakai, bahan desinfektan, sarung tangan, linen steril dan lain-lain). 2) Menghitung dan memastikan jumlah instrumen steril, bahan habis pakai yang akan dipakai (alat, kasa, jarum,

		<i>ringsponges</i>, dan lain-lain). b. Saat Pembedahan. 1) Membantu mengenakan baju operasi steril, sarung tangan untuk asisten bedah dan dokter bedah. 2) Menata instrumen di meja mayo. 3) Memberikan bahan disinfektan kepada asisten bedah/dokter bedah. 4) Memberikan linen steril untuk prosedur <i>drapping</i>. 5) Memberikan instrumen pada dokter sesuai dengan urutan prosedur pembedahan. 6) Menyiapkan benang jahit sesuai dengan kebutuhan. 7) Mempertahankan instrumen selama pembedahan dalam keadaan tersusun rapi dan steril. 8) Membersihkan instrumen dari darah sewaktu pembedahan untuk mempertahankan sterilitas alat dan meja mayo. 9) Menginstruksikan penghitungan instrumen yang dipakai dan bahan habis pakai (alat steril, kasa, <i>ringsponges</i>, jarum dan lain-lain kepada sirkulair). 10) Menyiapkan cairan untuk mencuci luka. 11) Membersihkan darah sekitar daerah operasi. 12) Membantu asisten bedah dalam proses menutup luka operasi dengan teknik steril. 13) Membantu asisten bedah menyiapkan pemeriksaan laboratorium patologi. c. Setelah Pembedahan. a. Menghitung dan memastikan alat yang dipakai ksesuai dengan persiapan awal. b. Menfiksasi drain dan kateter. c. Mengganti alat, linen, baju pasien serta memindahkan pasien dari meja operasi ke brankar. d. Membereskan dan merapikan kamar operasi. e. Membersihkan dan mencuci alat. f. Mengepak set instrumen. g. Membantu mensterilkan alat f. d. Tanggung Jawab
--	--	---

		a. Bertanggung jawab terhadap jumlah instrumen dan alat lainnya dalam pelaksanaan pembedahan yang dipakai baik pre operasi, intra dan pasca operasi. b. Bertanggung jawab terhadap alat doker yang dibawa dari luar rumah sakit. c. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan jumlah inventaris instrumen. e. Bertanggung jawab terhadap inventaris alat kesehatan
		e. Wewenang
		a. Mengusulkan kepada kepala perawat Instalasi Kamar Operasi untuk penambahan peralatan di Instalasi Kamar Operasi. b. Mengusulkan kepada kepala perawat Instalasi Kamar Operasi untuk penilaian kinerja perawat dan karyawan yang belajar instrumen. f. Mengusulkan untuk pengembangan karyawan.
No.	Nama Jabatan	a. Persyaratan Jabatan
6	Perawat Sircular/ Onloop	a. Pendidikan Minimal S1 Keperawatan b. Sertifikasi: Memiliki sertifikasi BCLS c. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja di kamar operasi minimal 3 bulan d. Keterampilan: 1) Memiliki sertifikasi instrumen dasar kamar operasi. 2) Memiliki sertifikasi <i>code blue</i>. 3) Memiliki sertifikasi penanggulangan bencana. b. Memiliki sertifikasi komunikasi efektif.
		▪ Uraian Tugas
		a. Sebelum Pembedahan. 1) Menyiapkan ruang operasi. 2) Menyiapkan kelengkapan operasi (meja operasi, suction, cauter, lampu operasi, dan lain-lain). 3) Menyiapkan berkas dan keperluan yang akan dipakai (kuitansi operasi, kwitansi alat, pemeriksaan PA). 4) Melakukan serah terima pasien dari ruangan.

			5) Mengoreksi status pasien/form operasi. 6) Memeriksa kelengkapan dokumen antara lain : a) <i>Informed concent.</i> b) Identitas pasien. c) Hasil laboratorium. d) Foto radiologi. e) Pemberian antibiotik. f) Mengecek penanda lokasi operasi. g) Instruksi / pesan dokter. h) Dan lain-lain. 7) Mengecek kelengkapan obat, cairan dan alat kesehatan. 8) Memberi penjelasan kepada pasien sebatas kewenangan tentang tindakan pembedahan, tim bedah, fasilitas yang ada di lingkungan kamar operasi. 9) Membantu mengatur posisi pasien sesuai jenis pembedahan. 10) Membantu anesthesi saat proses pembiusan bila diperlukan. 11) Menghitung dan memastikan instrumen steril dan bahan habis pakai bersama instrumen sebelum dilakukan tindakan operasi. 12) Memimpin dan membaca checklist keselamatan <i>pasien bedah</i>. b. Saat pembedahan. 1) Bersama asisten bedah mengatur posisi pasien, memasang arde cauter, suction, dan lampu. 2) Mengikat tali baju yang dipakai tim bedah. 3) Membantu mengukur, mencatat kehilangan darah, cairan dengan mengetahui jumlah produksi urine, jumlah darah, jumlah cairan yang hilang. 4) Memenuhi kebutuhan selama operasi berlangsung. 5) Bekerjasama dengan asisten anesthesi dalam memantau kondisi pasien selama pembedahan. 6) Melaporkan hasil pemantauan dan pencatatan kepada dokter anesthesi. 7) Menghubungi petugas penunjang medis (radiologi, laboratorium dan farmasi, perawat ruangan). 8) Melayani kebutuhan instrumen steril, bahan habis pakai, dan lain-lain yang diperlukan selama pembedahan berlangsung. 9) Menyiapkan bahan pemeriksaan	
--	--	--	---	--

			laboratorium patologi. 10) Bekerja sama dengan perawat instrumen dalam menghitung jumlah pemakaian instrumen, bahan habis pakai (alat steril, kassa, ringsponges, jarum dan lain-lain) sesuai jumlah awal persiapan. c. Setelah Pembedahan. 1) Mendampingi dokter bedah menulis laporan operasi dan menulis instruksi post operasi, kelengkapan status pasien. 2) Mengecek kelengkapan semua berkas-berkas post operasi. 3) Membantu asisten anestesi dan dokter membangunkan pasien sampai pasien sadar. 4) Menghitung dan memastikan alat yang dipakai sesuai dengan persiapan awal. 5) Membantu memindahkan pasien dari meja operasi ke brankar. 6) Mengecek dan mencatat pemakaian obat, bahan habis pakai, alat dokter dan alat kesehatan di lembar pemakaian. 7) Melakukan serah terima dengan petugas recovery room. 8) Membereskan dan merapikan kamar operasi. 9) Mengambil linen dan instrumen kotor. 10) Membersihkan dan mencuci linen. 11) Mencatat semua pemakaian instrumen steril. 12) Mengingatkan kembali petugas instrumen untuk melengkapi pemakaian alat dan kelengkapan tanda tangan. ▪ Membantu mengerjakan administrasi pasien	
			a. Tanggung Jawab	
			a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan jumlah instrumen dan bahan habis pakai yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan pembedahan. b. Bertanggung jawab terhadap pemakaian sewa alat rumah sakit, alat dokter dan alat kesehatan lainnya. c. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas–berkas pasien. d. Bertanggung jawab terhadap administrasi. b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan ruang kamar operasi.	

		a. Wewenang
		a. Melaporkan kepada kepala perawat Instalasi Kamar Operasi bila ada kerusakan alat operasi. b. Mengusulkan kepada kepala Instalasi Kamar Operasi untuk penilaian kinerja perawat dan karyawan yang belajar sirkulair
7	Nama Jabatan	a. Persyaratan Jabatan
	Perawat Anestesi	a. Pendidikan Lulusan S1 Keperawatan/ D4 Penata Anestesi b. Sertifikasi: Memiliki sertifikasi pelatihan anestesi c. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja di kamar operasi minimal 2 tahun d. Keterampilan: b. Memiliki Keterampilan dalam mengatasi kegawat daruratan pasien.
		o Uraian Tugas
		a. Pre anestesi. 1) Serah terima pasien. a) Memanggil pasien calon operasi 45' sebelum operasi. b) Serah terima pasien di ruang premedikasi dengan perawat ruangan. c) Mengkaji ulang persiapan dan keadaan pasien saat serah terima dari ruangan. d) Untuk pasien anak-anak saat serah terima sebaiknya di dampingi oleh orang tua sampai menjelang operasi. e) Mempersiapkan administrasi dan kelengkapan rekam medik pasien. f) Mengukur tanda-tanda vital dan mendokumentasikan dalam rekam medik pasien. 2) Sebelum pembiusan. a) Menyiapkan obat dan cairan yang diperlukan, termasuk obat – obat emergensi. b) Menyiapkan mesin anestesi, monitor jantung dan mesin suction serta melakukan tes terlebih dulu sebelum digunakan. c) Menyiapkan peralatan intubasi beserta perlengkapannya. d) Menyiapkan kelengkapan meja operasi

		antara lain standar infus, tali pengikat, bantal kepala. e) Mengecek kesediaan gas O₂ dan N₂O serta O₂ dorong. b. Anestesi Selama pembedahan. 1) Mengobservasi tanda-tanda vital pasien setiap 5' selama pembedahan. 2) Memberikan obat anestesi sesuai instruksi dokter. 3) Memenuhi keseimbangan O₂ dan N₂O dengan cara memantau flowmeter. 4) Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh yang hilang selama pembedahan. 5) Mendokumentasikan hasil pemantauan dalam rekam medik pasien. 6) Melaporkan hasil pemantauan kepada dokter spesialis anestesi. 7) Menjaga keamanan pasien dari bahaya jatuh. 8) Membantu melakukan resusitasi pada henti jantung. c. Post anestesi setelah pembedahan. 2) Mempertahankan jalan nafas pasien. 3) Memantau tanda-tanda vital pasien untuk mengetahui sirkulasi pernafasan, dan keseimbangan cairan. 4) Memantau tingkat kesadaran dan refleks pasien. 5) Menilai respon pasien terhadap efek obat anestesi. 6) Memindahkan pasien ke ruang pulih sadar / <i>recovery</i> atas perintah dokter spesialis anestesi. o Merapikan dan membersihkan alat-alat anestesi ke tempat semula agar siap digunakan lagi
		a. Tanggung Jawab
		a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan anestesi. b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan jumlah inventaris obat dan alat anestesi. c. Bertanggung jawab terhadap administrasi.
		h. Wewenang

		a. Mengusulkan untuk penambahan peralatan di anestesi. b. Mengusulkan untuk penambahan tenaga di anestesi. i. Mengusulkan untuk pengembangan SDM.
--	--	---

6.2 Tugas Klinis

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

A. Perawat Bedah

No.	Kompetensi
1.	Melakukan pengkajian pasien yang akan menjalankan operasi, selama operasi dan setelah operasi
2.	Melakukan analisa data hasil pengkajian
3.	Menentukan masalah/diagnosa keperawatan pasien
4.	Menyusun rencana asuhankeperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada
5.	Menerima pasien ore operasi
6.	Membuat resume keperawatan
7.	Melakukan reduksi ansietas pada pasien
8.	Menghitung balance cairan
9.	Melakukan pemantauan hemodinamik selama dan setelah operasi
10.	Menilai status cairan
11.	Memakai topi dan masker operasi
12.	Memakai jas operasi
13.	Memakai APD
14.	Melakukan cuci tangan bedah
15.	Memakai sarung tangan operasi
16.	Memahami lokasi operasi
17.	Mengidentifikasi kesiapan pasien operasi
18.	Memberi penyuluhan sebelum operasi
19.	Memberi bimbingan rohani pasien
20.	Menerima pasien operasi
21.	Persiapan obat alkes operasi
22.	Melakukan verifikasi pasien operasi
23.	Menyiapkan meja operasi
24.	Menyiapkan set linen operasi
25.	Mampu menjadi sirkuler
26.	Melakukan penghitungan kasa sebelum dan sesudah operasi
27.	Melakukan perhitungan instrumen sebelum dan sesudah operasi prosedur drapping
28.	Melakukan prosedur time out
29.	Monitoring pasien selama pembedahan
30.	Mendokumentasikan askep pasien kamar operasi
31.	Penanganan pasien meninggal di kamar operasi
32.	Menyerahkan pasien post op dengan petugas rawat inap

33.	Melakukan serah terima pasien di ruang ICU
34.	Observasi pasien pasca anestesi dan pembedahan di RR
35.	Melakukan pengelolaan spesimen
36.	Melakukan serah terima spesimen dengan petugas laboratorium/ keluarga
37.	Melakukan pembersihan kamar operasi
38.	Melakukan pengelolaan instrumen pasca operasi
39.	Melakukan sterilisasi kasa
40.	Pemeliharaan alat kesehatan dan alat medik di kamar operasi
41.	Penyusunan set instrumen dan memberi label
42.	Melakukan sterilisasi linen
43.	Melakukan penanganan alat steril
44.	Mengoperasikan alat-alat kesehatan dan alat medis
45.	Pemeliharaan alat kesehatan dan alat medis di kamar operasi

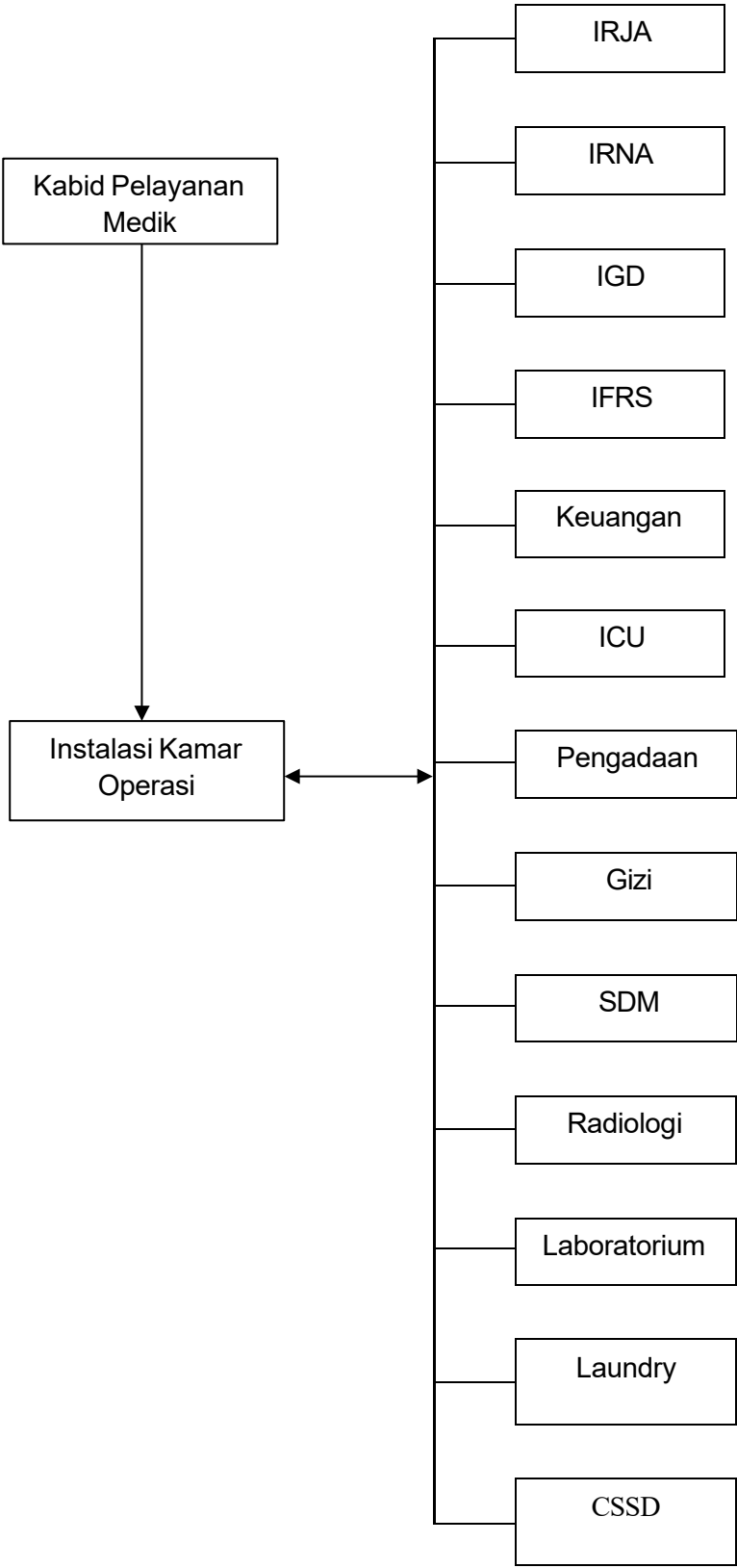
B. Perawat Anestesi

No	KOMPETENSI
1	Melakukan assesmen keperawatan pada individu
2	Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif
3	Membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif
4	Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif
5	Memantau perkembangan pasiensesuai dengan kondisinya (melakukan pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien) pada individu dalam rangka upaya preventif
6	Memfasilitasi penggunaan pelindung diri pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif
7	Memberikan oksigenasi sederhana
8	Memberikan bantuan hidup dasar
9	Melakukan pengukuran antropometri
10	Melakukan pengkajian nutrisiional
11	Melakukan fasilitasi pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasi
12	Memantau keseimbangan
13	Melakukan mobilisasi posisi pasien
14	Mempertahankan posisi anatomis pasien
15	Melakukan fiksasi fisik
16	Memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat
17	Memfasilitasi kebiasaan tidur pasien
18	Melakukan pemeliharaan diri pasien
19	Memandikan pasien
20	Membersihkan mulut pasien
21	Melakukan kegiatan kompres hangat/dingin
22	Mempertahankan suhu tubuh saat tindakan (memasang <i>warming blanket</i>)
23	Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan
24	Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (<i>dying care</i>)
25	Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal

27	Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka, dan kematian
28	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman
29	Melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan
30	Menyusun rencana kegiatan individu perawat
31	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan
32	Melaksanakan tugas lapangan dibidang kesehatan
33	Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu
34	Melakukan supervisi lapangan

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA



-
1. Hubungan kerja dengan Kabid Pelayanan Medik:
 - a. Pelaporan dari Instalasi Kamar Operasi tentang seluruh kegiatan yang dilakukan bagian masing-masing.
 - b. Berkoordinasi bersama-sama mencari solusi berkaitan dengan masalah yang terjadi di kamar operasi.
 2. Hubungan kerja dengan Instalasi Rawat Jalan :
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan tindakan pembedahan yang akan dilakukan.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi mendapat jadwal rencana operasi yang akan dilakukan jika pasien berasal dari Instalasi Rawat Jalan.
 - c. Petugas Instalasi Kamar Operasi konfirmasi pasien yang akan operasi pada hari ini.
 - d. Petugas Instalasi Kamar Operasi mendapat konfirmasi dari petugas rawat jalan bila pasien sudah siap.
 - e. Petugas Instalasi Kamar Operasi memeriksa kelengkapan status rekam medis pasien berupa *inform consent*, persetujuan tarif operasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, EKG dan lain-lainnya.
 - f. Petugas Instalasi Kamar Operasi menerima pasien dan menyiapkan kelengkapan status rekam medis yang diperlukan untuk kemudian dilakukan operasi.
 3. Hubungan kerja dengan Instalasi Rawat Inap :
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan tindakan pembedahan yang akan dilakukan.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi setiap pagi melakukan konfirmasi ke setiap ruang tentang jadwal operasi pada hari ini.
 - c. Petugas Instalasi Kamar Operasi memeriksa kelengkapan status rekam medis pasien berupa *inform consent*, persetujuan tarif operasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, EKG, dan lain-lainnya.
 - d. Petugas Instalasi Kamar Operasi menghubungi perawat ruangan untuk mengirim pasien yang akan dilakukan operasi.
 4. Hubungan Kerja Dengan Instalasi Gawat Darurat:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan tindakan pembedahan yang akan dilakukan.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi mendapat konfirmasi dari Instalasi Gawat Darurat bila pasien telah siap untuk di antar Instalasi Kamar Operasi.
 - c. Petugas Instalasi Kamar Operasi menghubungi petugas Instalasi Gawat Darurat jika Instalasi Kamar Operasi siap digunakan.
 - d. Petugas Instalasi Kamar Operasi memeriksa kelengkapan status rekam medis pasien berupa *inform consent*, persetujuan tarif operasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, EKG dan lain-lainnya.
 5. Hubungan Kerja Dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan pemakaian alat kesehatan dan obat yang dipakai saat operasi.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi melakukan inventaris harian terhadap alat dan obat yang dipakai.
 - c. Menulis nama obat dan bahan habis pakai dalam buku permintaan dan ditanda tangani oleh Kepala Ruang Instalasi Kamar Operasi.
 - d. Mengantar buku permintaan alat kesehatan dan obat habis pakai ke IFRS.
 6. Hubungan Kerja dengan Keuangan:
 - a. Berkoordinasi berkaitan harga operasi dan harga alkes.

-
7. Hubungan Kerja dengan *Intensive Care Unit*:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan tindakan pembedahan yang akan dilakukan dan perawatan setelah dilakukan operasi.
 - b. Perawat Instalasi Kamar Operasi memesan tempat bila pasien memerlukan ruang ICU.
 - c. Perawat Instalasi Kamar Operasi menghubungi perawat ICU untuk menjemput pasien dan melakukan serah terima status pasien.
 8. Hubungan kerja dengan pengadaan:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan permintaan barang yang dibutuhkan Instalasi Kamar Operasi. Perawat Instalasi Kamar Operasi membuat permintaan di buku permintaan ke bagian pengadaan yang ditanda tangani oleh kepala perawat Instalasi Kamar Operasi.
 - b. Perawat Instalasi Kamar Operasi mengantar buku permintaan ke bagian pengadaan.
 9. Hubungan kerja dengan SDM:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
 - b. Berkoordinasi berkaitan kegiatan pendidikan dan latihan pegawai.
 10. Hubungan kerja dengan radiologi:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan permintaan foto rontgen.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi menelepon/menghubungi petugas radiologi bila diperlukan foto rontgen.
 11. Hubungan kerja dengan laboratorium:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan pengiriman *specimen*.
 - b. Berkoordinasi berkaitan dengan pengambilan *specimen*.
 - c. Berkoordinasi berkaitan dengan pengambilan pemeriksaan laborat (darah, kultur, pus, dan lain-lain).
 12. Hubungan kerja dengan bagian Laundry:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan perbaikan dan kebutuhan linen.
 - b. Berkoordinasi berkaitan dengan inventaris barang rumah tangga di Instalasi Kamar Operasi.
 - c. Berkoordinasi berkaitan dengan pencucian linen operasi.
 - d. Petugas binatu menerima linen kotor dari petugas kamar operasi.
 - e. Petugas binatu menerima dan dilakukan pengecekan.
 - f. Petugas binatu mengantar linen yang sudah bersih.
 13. Hubungan kerja dengan CSSD:
 - a. Berkoordinasi berkaitan dengan pencucian alat, pengepakan alat dan penyeterilan alat.
 - b. Petugas Instalasi Kamar Operasi menyerahkan instrument yang telah dipakai ke Instalasi Pusat Sterilisasi.
 - c. Petugas Instalasi Pusat Sterilisasi mencuci dan mengepak serta menyeteril alat.
 - d. Alat dikembalikan ke Instalasi Kamar Operasi.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

8.1 Pola Ketenagaan

Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf dalam upaya mempersiapkan tenaga perawat yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Dasar perhitungan tenaga di IKO menggunakan Depkes RI 2005, dengan ketentuan:

1. Jumlah dan jenis operasi.
2. Jumlah Kamar operasi.
3. Pemakaian kamar operasi pada hari kerja.
4. Tugas perawat di kamar operasi terdiri dari instrumen, sirkulair (orang/tim).
5. Ketergantungan pasien
 - a. Operasi khusus (± 3 jam per satu operasi).
 - b. Operasi besar (± 2 jam per satu operasi).
 - c. Operasi sedang (± 1 jam per satu operasi)
 - d. Operasi kecil (± 1 jam per satu operasi)

Perhitungan tenaga instalasi kamar operasi Rata-rata operasi dalam 1 hari : 6 pasien/ hari

Khusus	1
Besar	5
Sedang	0
Kecil	0

1. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Rumus :

$(\text{Jumlah jam operasi/hari} \times \text{jumlah operasi}) \times \text{jumlah perawat dalam tim} + 1 \text{ (cadangan)}$ Jam kerja efektif/
hari

$$\begin{aligned} &= \frac{\{(3 \times 1) + (2 \times 5)\} \times 3 + 1}{7} \\ &= \frac{(3 + 10) \times 3 + 1}{7} \\ &= \frac{13 \times 3 + 1}{7} \\ &= 5.7 = 6 \text{ orang} \end{aligned}$$

2. Faktor Koreksi

- a. Hari libur/cuti/hari besar(loss day)

$\text{Jml hari minggu dlm 1th} + \text{cuti} + \text{hari besar} \times \text{jml perawat tersedia}$ Jumlah hari kerja efektif

$$\frac{52 + 12 + 14}{6}$$

$$286$$

$$= 1.64$$

$$= 2$$

b. Jumlah tenaga keperawatan yang mengerjakan tugas non job 25% dari total kebutuhan perawat

$$(5+2) \times 25\%$$

$$=1.75$$

$$= 2$$

TOTAL KEBUTUHAN TENAGA

$$= 6 + 2 + 2$$

$$= 10 \text{ orang}$$

3. Perhitungan tenaga ruang penerimaan dan recovery room
Ketergantungan pasien :

Ruang penerimaan : 30 menit

Recovery room : 3 jam

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah jam} \times \text{jumlah operasi}}{\text{Jam kerja efektif/ hari}}$$

$$= \frac{3 \times 6}{7}$$

$$= 2.6$$

$$= 3 \text{ orang}$$

Jadi total tenaga di Instalasi kamar operasi adalah :

- 1. Bedah : 10 orang
- 2. Ruang penerima dan RR : 3 orang

Jabatan	Jumlah SDM		
	Standar	Tersedia	Kebutuhan
Ka Instalasi	1	1	0
Ka Ruang	1	1	0
Asisten Anestesi	3	2	1
Bedah	10	8	2
RR	3	3	0

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuutan tenaga Instalasi Kamar Operasi yang dibutuhkan untuk penambahan karyawan:

- a. Bedah 2 orang
- b. Anestesi 1 orang

8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf
 - a. Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - b. Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
2. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama; Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
2. Seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya; bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

- 1. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- 2. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- 3. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- 4. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.4 Jumlah Staf Unit

Tabel 8.1 Kualifikasi Ketenagaan Instalasi Rawat Inap

NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI	JUMLAH SAAT INI	JUMLAH KEBUTUHAN
Ka Instalasi	Dokter/Spesialis	ACLS/BCLS Code Blue HIPERKES PMKP	1	0
Ka Ruangan	S1 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	1	0
Perawat pelaksana	D3 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	11	3

8.5 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Gawat Darurat memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

- 1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husadasendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)
Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar perawat IKO RS Prima Husada :

1. Perawat Asisten Operator/ Instrumen
 - a. Lulusan S1 Keperawatan
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan instrumentasi kamar operasi
 - f. Memiliki pemahaman tentang kamar operasi dengan baik.
 - g. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.
2. Tenaga Penata Anestesi
 - a. Lulusan S1 Keperawatan/ D4 Penata anestesi
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memahami pekerjaan penata anestesi
 - f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.

8.6 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan keperawatan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Pendidikan
Tenaga dengan pendidikan setingkat Diploma III diberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners.
2. Pelatihan
Pelatihan untuk peningkatan kompetensi asisten operator, instrumen dan penata anestesi dilaksanakan melalui:
 - a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD
 - b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Kamar Operasi.

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

Kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat RS Prima Husada, antara lain adalah sebagai berikut :

9.1 Orientasi tenaga medis :

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	1. Penjelasan status kepegawaian 2. Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi 3. Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada 4. Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan 5. Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : a. Visi, misi, nilai, struktur organisasi b. Perjanjian kerja c. Etika bekerja d. Kesejahteraan spiritual e. Service excellence f. Handling complaints g. Produk produk rumah sakit h. <i>Basic life support</i> i. Penanggulangan bencana kebakaran j. Patient safety k. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2.	Orientasi secara garis besar: a. Tentang pengertian Instalasi Kamar Operasi. b. Sosialisasi Falsafah dan tujuan, visi misi, motto, struktur organisasi kamar operasi. c. Jadwal dinas.	7 Jam	a. Pembela jaran b. Tanya jawab	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi.

3.	Prosedur penerimaan pasien operasi dari instalasi rawat inap.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab c. Survey lapangan.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
4.	Prosedur penerimaan pasien operasi dari Instalasi Gawat Darurat.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Survey lapangan.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
5.	Prosedur penerimaan pasien ODC.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Survey lapangan.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
6.	Prosedur tugas dinas pagi, sore dan malam.	4 Jam	a. Pembelajaran d. Tanya jawab.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
7.	Prosedur alur masuk pasien.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
8.	Prosedur alur keluar pasien.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
9.	Prosedur alur masuk alat steril.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. b. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
10.	Prosedur keluar alat kotor.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
11.	Prosedur serah terima pasien.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
12.	Prosedur penggunaan <i>cauter</i> .	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang berkompeten.

13.	Prosedur penggunaan <i>suction</i> .	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
14.	Prosedur Pengambilan Linen Kotor/ pembersihan linen/ pengiriman ke binatu.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
15.	Prosedur Pengambilan Alat steril.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
16.	Prosedur penggunaan memert.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang berkompeten.
17.	Prosedur pembersihan instrumen.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang berkompeten.
18.	Prosedur packing instrumen.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
19.	Prosedur penataan instrumen di meja besar dan meja mayo.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
20.	Penggunaan alat untuk bermacam-macam operasi.	4 Jam	a. Pembelajaran b. Tanya jawab. c. Praktek.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi/ perawat IKO yang Berkompeten.
21.	Evaluasi.	4	a. Ujian tulis b. Ujian lisan.	Kepala Perawat Instalasi Kamar Operasi.

BAB X

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional di Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi Kamar Operasi
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi Kamar operasi.

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

Rapat Rutin

1. Rapat rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Satu bulan sekali.

Tempat : Ruang Pertemuan IKO RS Prima Husada.

Peserta : Ka. Inst Kamar Operasi, Kepala Ruang IKO, Perawat pelaksana.

Materi : a. Evaluasi kinerja.
b. Evaluasi SDM.

1) Evaluasi terhadap materi dan pelaksanaan pelayanan IKO.

2) Perencanaan dan upaya peningkatan kinerja SDM dan pelayanan IKO.

3) Rekomendasi dan usulan untuk peningkatan kinerja pelayanan IKO.

Kelengkapan rapat : Undangan, daftar hadir, notulen rapat, laporan/usulan/ rekomendasi kepada pimpinan.

Rapat Insidentil

1. Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

PELAPORAN

11.1 Pengertian

Pelaporan merupakan sistim atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan pemberian pelayanan anestesi dan bedah di kamar operasi.

11.2 Jenis Laporan

Laporan dibuat oleh kepala IKO. Adapun jenis laporan yang dikerjakan terdiri dari:

1. Laporan Harian

Laporan yang dibuat oleh Penanggung Jawab Shift dalam bentuk tertulis setiap hari. Adapun hal – hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan kunjungan pasien kamar operasi
- b. Laporan SDM IKO
- c. Laporan keadaan sarana dan fasilitas IKO
- d. Laporan mutu pelayanan

2. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh kepala ruang IKO dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada kepala instalasi. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan jumlah operasi dalam satu bulan
- b. Laporan hasil capaian mutu.

3. Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Ka unit dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada Kabid Pelayanan dan Penunjang. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan kunjungan pasien IKO dan Evaluasi dalam 1 tahun.
- b. SDM / Ketenagaan di IKO dan evaluasi dalam 1 tahun.
- c. Laporan keadaan fasilitas dan sarana di IKO dan evaluasi dalam 1 tahun.
- d. Laporan mutu pelayanan IKO.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah